

Item 277

Lithiase biliaire et complications

Colique hépatique · Cholécystite · Migration · Angiocholite · Pancréatite

Résumé
structuré du
cours
Rangs A & B

1. Définitions [Rang A]

Lithiase biliaire	Présence de calcul(s) dans l'arbre biliaire (vésicule et/ou VBP) formés à partir de la bile
Colique hépatique	Douleur par mise en tension <i>brutale</i> des voies biliaires → blocage transitoire d'un calcul dans le canal cystique ou la VBP
Cholécystite aiguë	Infection aiguë de la vésicule par obstruction prolongée du canal cystique → cholécystite aiguë lithiasique
Angiocholite	Infection bactérienne de la VBP par enclavement d'un calcul au niveau de l' ampoule de Vater
Pancréatite aiguë	Inflammation aiguë du pancréas par migration d'un calcul dans l'ampoule de Vater

2. Épidémiologie [Rang B]

Prévalence générale 20 % en population occid.	Après 80 ans 60 % de la population	Asymptomatiques 80 % des porteurs	Risque de complication 20 % cumulé
---	--	---	--

■ Pas d'indication au **dépistage systématique** — 80 % asymptomatiques, probabilité cumulée de complication = 20 %

3. Types de calculs & Facteurs de risque [Rang B]

Calculs cholestéroliques — 80 % <i>Mécanisme</i> : sursaturation de la bile en cholestérol → précipitation Mnémotechnique — règle des 5F : • Female (sexe féminin) • Fertile (grossesse) • Fat (surpoids / obésité) • Forty (âge avancé) • Fasting (jeûne prolongé, nutrition parentérale) • Chirurgie bariatrique (gastrectomie, bypass) • Médicaments : œstrogènes, fibrates, analogues somatostatine	Calculs pigmentaires — 20 % <i>Mécanisme</i> : précipitation de bilirubine non conjuguée (insoluble) Facteurs de risque : • ↑ production bilirubine : hémolyse, drépanocytose, thalassémie • Obstacles biliaires • Infections biliaires chroniques • Origine géographique (Asie)
--	--

4. Complications — Mécanismes & Présentation clinique [Rang A]

4.1 Colique hépatique [Rang A]

Sémiologie • Douleur brutale, intense, continue (crampe ou broiement) • Siège : épigastre ou hypochondre droit • Irradiation : héli-ceinture, omoplate / épaule droite • Durée < 6 h • Nausées, vomissements, inhibition inspiratoire	Examen & DD • Signe de Murphy : palpation HD → douleur inhibant l'inspiration profonde 3 diagnostics différentiels à éliminer : • Syndrome coronarien aigu • Ulcère gastroduodénal • Pancréatite aiguë
--	--

4.2 Cholécystite aiguë lithiasique [Rang A]

• Douleur HD + défense • Fièvre, frissons • Signe de Murphy +	• Hyperleucocytose PNN • ↑ CRP et/ou PCT • Bilan hépatique NORMAL	• Paroi vésiculaire > 4 mm (triple feuillet) • Distension vésiculaire • Calcul(s) visible(s)
---	--	--

4.3 Migration lithiasique [Rang A]

Mécanisme & Clinique • Passage de petits calculs dans la VBP • Sans signe d'angiocholite ni de pancréatite • Pas de fièvre • Bilan hépatique perturbé	Biologie & Imagerie • ↑↑ Transaminases — souvent importantes • Diminution > 50 % en moins de 48 h (signe clé) • Écho : calculs vésiculaires, rarement dilatation VBP
--	---

4.4 Angiocholite aiguë [Rang A]

Triade de Charcot (présente de façon inconstante) : Douleur biliaire → Fièvre → Ictère, apparus **successivement en 48 h**.
En l'absence de la triade : cholestase (ictérique ou non) + syndrome infectieux/inflammatoire.

• **Complications évolutives** : abcès hépatiques • choc septique • défaillance multiviscérale → décès

5. Tableau comparatif — Diagnostic différentiel [Rang A]

Colique hépatique	Non	Normal	Normales	Échographie (Se 95 %)
Cholécystite aiguë	Oui	Normal	Normales	Échographie (paroi > 4 mm)
Migration lithiasique	Non	Perturbée	↑↑ puis -50 % < 48 h	Écho (peu sensible) Bili-IRM / Écho-endo
Angiocholite	Oui	Cholestase	Élevées	Échographie ± Scanner

6. Examens d'imagerie [Rang A]

Lithiasie sympto. simple	Échographie abdominale	Scanner / Bili-IRM	Se écho = 95 % pour calculs vésiculaires
Cholécystite aiguë	Échographie abdominale	Scanner abdominal	Paroi > 4 mm, distension, calculs
Migration lithiasique (calcul VBP ?)	Échographie (peu sensible)	Bili-IRM ou Écho-endoscopie	TDM < Bili-IRM pour calculs cholédociens

Angiocholite	Échographie abdominale	Scanner si écho non contributive (± IRM / Écho-endo en 3 ^e ligne)	Cherche : lithiase vésiculaire + dilatation VBP
--------------	------------------------	--	---

7. Traitement [Rang A]

7.1 Lithiase symptomatique non compliquée [Rang A]

- Traitement antalgique de la crise
- Cholécystectomie dans le **mois** suivant (éviter récurrence ou complication)

7.2 Cholécystite aiguë [Rang A]

Traitement	Complications
• Antalgiques • Antibiothérapie large spectre (germes digestifs) → adaptée antibiogramme • Cholécystectomie en urgence (le plus tôt possible)	Complications septiques à connaître : • Abscess péri-vésiculaire ou hépatique • Péritonite biliaire (perforation vésiculaire) • Fistule bilio-digestive

7.3 Angiocholite aiguë [Rang B]

Étape 1 — Traitement médical	Étape 2 — Désobstruction VBP en urgence
• Antalgiques • Antibiothérapie large spectre sans délai (après prélèvements bactériologiques) • Prise en charge réanimatoire si sepsis sévère : remplissage, amines vasopresseurs	• Voie endoscopique (CPRE) en 1^{re} intention • Si indisponible ou échec : drainage percutané • CPRE : duodéno-scopie à vision latérale, sous AG sphinctérotomie + extraction instrumentale du calcul • Cholécystectomie différée selon le terrain

7.4 Désobstruction VBP hors urgence septique (lithiase cholédocienne) [Rang B]

Option 1 — En 1 temps chirurgical	Option 2 — En 2 temps
• Cholécystectomie + désobstruction per-opératoire de la VBP	• CPRE (sphinctérotomie endoscopique) • Puis cholécystectomie

8. Pièges à éviter [Rang A]

■ Bilan hépatique anormal dans la cholécystite ?	→ Non — le bilan hépatique est normal dans la cholécystite. Une perturbation du bilan hépatique oriente vers une migration lithiasique ou une angiocholite.
■ Triade de Charcot toujours présente dans l'angiocholite ?	→ Non — la triade (douleur / fièvre / ictère) est inconstante . Penser à l'angiocholite devant toute association cholestase + syndrome infectieux.
■ Dépistage systématique de la lithiase vésiculaire ?	→ Pas indiqué — 80 % des porteurs sont asymptomatiques et le risque cumulé de complication est de 20 %.
■ Échographie suffisante pour un calcul du cholédoque ?	→ Non — l'échographie a une mauvaise sensibilité pour les calculs de la VBP. Privilégier Bili-IRM ou écho-endoscopie.
■ En cas de choc septique sur angiocholite, désobstruer en urgence immédiate ?	→ Non — la réanimation prime (remplissage, amines, ATB). La désobstruction ne peut être envisagée qu'après stabilisation.